



認識心絞痛

心臟的血管變窄，供血跟不上需求時，胸口就會發出警訊

它是提醒，不是終點——控制得好，可以過正常生活



掃描看電子版

① 什麼是心絞痛？



血流順暢

脂肪斑塊讓管腔變窄

心臟自己也需要血液。冠狀動脈因斑塊變窄時，用力或情緒激動就會供血不足，心肌缺氧而胸悶痛。

② 危險因子有哪些？

紅=可改變 灰=不可改變



抽菸



高血壓



高血脂



糖尿病



肥胖



久坐不動



壓力、睡不好



年齡、家族史

心絞痛與心肌梗塞

同一條血管的三階段



斑塊變窄
= 心絞痛



表面破裂
= 不穩定型



血栓塞住
= 心肌梗塞

心絞痛是警訊，也是提早處理的機會。

更痛、更久或休息時也發作 → 立刻就醫

③ 有哪些症狀？

左：典型 右：不典型（容易被忽略）



胸口悶、壓、緊



傳到左肩、
手臂、下巴



用力時才發作



休息幾分鐘
就緩解



只覺得喘



冒冷汗、疲倦



噁心、想吐



像胃痛、牙痛
或背痛

不典型症狀在女性、糖尿病與長者特別常見——判斷訣竅是看「情境」：只要每次都在出力時出現、休息就好，就要懷疑。

④ 醫師會做什麼檢查？

依症狀與風險高低選擇，不是每一項都要做

基本 心電圖、抽血（心肌酵素、血脂、血糖、腎功能）、心臟超音波

看缺氧 運動心電圖、核子醫學心肌灌注掃描、運動或藥物負荷心臟超音波

看血管 電腦斷層冠狀動脈攝影（非侵入性）；心導管冠狀動脈攝影是確診與治療的黃金標準

⑤ 有哪些治療？

藥物是所有人的基礎；是否放支架或開刀，依血管狹窄程度與症狀決定

藥物治療（基礎）

抗血小板藥、statin、
乙型阻斷劑、硝酸甘油等

心導管介入（放支架）

從手腕或鼠蹊部放入導管，
撐開狹窄處並置放支架

冠狀動脈繞道手術

多條或左主幹嚴重阻塞、
合併糖尿病者常優先考慮

⑥ 我要配合做什麼？

目標值請以醫師為您設定的為準

壞膽固醇 LDL

< 70 mg/dL

居家血壓

< 130 / 80 mmHg

糖化血色素

一般 < 7%

身體質量指數

BMI 18.5~24

運動 每週 150 分鐘中等強度（快走、騎車）；先問醫師可以做到什麼程度

飲食 少油少鹽少糖、多蔬果全穀與魚；戒菸是所有措施中效益最大的一項

放過支架者的抗血小板藥，未經醫師同意絕對不可自行停用。

⑦ 出現這些情況，立即撥打 119

胸痛持續超過 15~20 分鐘不緩解 | 休息時也發作 | 比平常更痛、更頻繁 | 冒冷汗、喘、快昏倒

舌下含片用法 坐下含 1 錠；5 分鐘沒改善或更嚴重 → 立刻打 119，不要等含滿 3 錠。

等救護車時，每 5 分鐘可再含 1 錠，最多共 3 錠。

切勿與壯陽藥（威而鋼等）併用，可能造成嚴重低血壓。